

02 - 02- Le Syndrome De La Queue De Cheval - Pr. Ghannane

(0:00 - 0:37)

Bonjour tout le monde, le cours d'aujourd'hui traitera le syndrome de la queue de cheval. Le syndrome de la queue de cheval se définit quand l'ensemble des manifestations cliniques secondaires à une compression des racines de la queue de cheval, c'est-à-dire l'ensemble des racines nerveuses qui se projettent dans l'espace compris entre la deuxième vertèbre lombaire et la cinquième vertèbre sacrée. Comme la compression médullaire, le syndrome de la queue de cheval peut avoir de nombreuses idéologies.

(0:37 - 0:59)

Son diagnostic est clinique, comme le syndrome de la compression médullaire. L'imagerie trouve son intérêt dans la mise en évidence de la cause responsable de ce syndrome de la queue de cheval. C'est une pathologie grave comme la compression médullaire parce qu'elle expose un risque de troubles neurologiques qui peuvent être irréversibles.

(0:59 - 1:29)

De ce fait, le syndrome de la queue de cheval constitue une urgence non plus thérapeutique mais aussi diagnostique. Comme rappel anatomique, nous avons la moelle épinière qui est contenue dans le canal rachidien. Elle commence au niveau de la première vertèbre cervicale et s'arrête en regard de l'espace L1 et L2.

(1:30 - 1:54)

Tout ce qui vient après, ce sont les racines de la queue de cheval. Les racines de la queue de cheval sont situées dans l'espace compris entre la deuxième vertèbre lombaire et la cinquième vertèbre sacrée. Toujours dans ce chapitre de rappel anatomique, voici quelques repères cliniques des racines lombaires et sacrées.

(1:54 - 2:23)

La première racine nerveuse L1 gère la motricité du psoas et des muscles adducteurs de la cuisse. La troisième et la quatrième racines nerveuses lombaires interviennent dans la motricité des muscles quadriceps. La quatrième et la cinquième racines nerveuses lombaires gèrent la motricité de la loge antérieure et antéroexterne de la jambe.

(2:24 - 2:53)

Un autre élément, c'est que cette quatrième racine nerveuse lombaire est sous la dépendance du réflexe rotulien. La première racine nerveuse sacrée est gérée par le réflexe achillien. Cette première racine nerveuse sacrée gère la motricité de la loge antéropostérieure de la jambe.

(2:54 - 3:28)

La deuxième et la quatrième racines nerveuses sacrées interviennent dans les phénomènes de miction et de défécation. Comment va se manifester cliniquement le syndrome de la côte chevale? Sur le plan clinique, il faudra retenir que ce syndrome, c'est un syndrome nerveux périphérique. Il n'est pas central comme c'est le cas pour le syndrome de la compression midi-lèvre.

(3:29 - 3:46)

Dans la compression midi-lèvre, c'est la moelle épinière qui est comprimée. Comme la moelle épinière fait partie du système nerveux central, on va avoir une atteinte nerveuse centrale. Alors que dans la côte chevale, ce ne sont que les racines nerveuses qui sont comprimées.

(3:48 - 4:18)

Ce syndrome de la côte chevale est un syndrome périphérique. Il est fait par un certain nombre de signes cliniques qui sont une douleur associée à une paresthésie unie au bilatéral des deux membres inférieurs du périnée. Et souvent, cette douleur est polyradiculaire, c'est-à-dire qu'elle intéresse plusieurs racines nerveuses.

(4:19 - 5:01)

A côté de cette douleur, le malade va présenter un déficit sensitif à tous les modes. Entre autres, ce qu'on appelle une anesthésie en selle, c'est-à-dire une anesthésie qui intéresse le territoire cutané situé, compris, entre les organes génitaux externes et la fourchette anal. Et donc, cette anesthésie en selle, c'est un signe important, c'est un signe sensitif important dans le tableau clinique de la queue de cheval.

(5:01 - 5:31)

Donc, nous avons des douleurs paresthésiantes unies au bilatéral des membres inférieurs du périnée. Un déficit sensitif à tous les modes des membres inférieurs et de la région de la selle, comprise entre la fourchette anal et les organes génitaux externes. Et aussi un déficit moteur des deux membres inférieurs, avec des réflexes ostéotendineux qui sont diminués ou carrément abolés aux deux membres inférieurs.

(5:32 - 6:23)

A côté de cela, le malade présente des troubles sphinctériens et génitaux à type d'une incontinence ou une rétention urinaire et ou anal associés à des troubles sexuels à type d'impuissance sexuelle. A côté de cela, le malade peut présenter en plus des troubles trophiques à type d'amiotrophie ou des scars des membres inférieurs ou du périnée. Un signe important, c'est que dans le syndrome de la côte chevale, on n'a jamais de signes d'irritation pyramidale,

c'est-à-dire qu'on n'a jamais de réflexes qui sont vifs polycynithiques, on n'a jamais d'irritation de trépidation épileptoïde, jamais de clonistes de la rotule.

(6:23 - 7:03)

Si on a des signes d'irritation pyramidale, on n'a plus le droit de parler du syndrome de la côte chevale, mais il faut chercher une atteinte centrale, notamment au niveau de la moelle épinière ou au niveau du cerveau. C'est une notion qui est importante, jamais de signes d'irritation pyramidale dans le syndrome de la côte chevale. Le syndrome de la côte chevale, c'est un syndrome dont le diagnostic est basé sur la clinique, c'est-à-dire sur les signes fonctionnels rapportés par le malade et les signes physiques mis en évidence par l'examineur.

(7:03 - 7:38)

Le bilan paraclinique trouve son intérêt dans la recherche d'une étiologie, c'est-à-dire d'une cause responsable de cette compression de la queue de cheval. L'examen paraclinique a demandé est le même que celui qu'on demande quand on suspecte une compression médullaire. Avec comme examen paraclinique clé, la réalisation d'une IRM lombaire est sacrée.

(7:38 - 8:19)

Toute suspicion d'un syndrome de la côte chevale doit nous faire réaliser en urgence une IRM vertébrale lombaire et sacrée. Éventuellement, on peut demander une radiographie standard du rachis lombo-sacré, mais la réalisation de cette radiographie standard ne doit en aucun cas retarder la réalisation d'une IRM. Et si l'IRM n'est pas disponible, on peut se débrouiller par la réalisation d'un scanner lombo-sacré.

(8:20 - 8:59)

Mais retenez que l'examen paraclinique de référence à réaliser chez un malade qui présente un syndrome de la côte chevale reste de loin l'IRM. Les causes de ce syndrome de la côte chevale, nous avons dit qu'il y a plusieurs causes et ces causes peuvent être divisées en deux grandes catégories. Il y a les causes extradurales et il y a les causes intradurales.

(9:00 - 9:53)

Comme causes extradurales, on peut avoir les hernies discales lombaires, le canal lombaire étroit, les tumeurs vertébrales lombaires primitives malignes ou bénignes ou secondaires, c'est-à-dire les métastases. Et aussi les causes infectieuses, notamment les spondylodécides lombaires et sacrés et ces spondylodécides peuvent être d'origine tuberculeuse ou secondaire à des germes banaux. Voici quelques exemples, voici une grosse hernie discale lombaire qui comprime les racines de la queue de cheval et qui peut être responsable d'un syndrome de la côte chevale.

(9:53 - 10:51)

Ça c'est un scanner où on voit la hernie, ça c'est une IRM où on voit la hernie discale, grosse hernie discale qui comprime les racines de la queue de cheval à ce niveau et qui peut être une des causes de ce syndrome de la queue de cheval. Le canal lombaire étroit, donc c'est un canal lombaire rétréci, étroit et à cause de cette étroitesse du canal, les racines nerveuses de la queue de cheval peuvent être comprimées et être responsables sur le plan clinique d'un syndrome de la queue de cheval par un canal lombaire étroit. Voici l'aspect, ça c'est un scanner et ça c'est l'IRM où vous voyez l'étroitesse du canal lombaire à ce niveau.

(10:53 - 13:21)

Donc le syndrome de la queue de cheval, il peut être lié à des causes extradurales qu'on a vu, dominées par les hernies discales lombaires, le canal lombaire étroit, les tumeurs vertébrales lombaires et sacrées et les spondylodécides. À côté de ces causes extradurales, on peut avoir des causes intradurales et ces causes intradurales, elles sont dominées par deux idéologies fréquentes qui sont le norinome de la queue de cheval et nous avons dit que le norinome de la queue de cheval, c'est une tumeur nerveuse généralement bénigne et qui résulte d'une prolifération de la gaine de cheval entourant donc les racines nerveuses. Et cette cellule de cheval, il peut proliférer et être responsable d'une tumeur appelée norinome rachidienne ou chevanome.

Dans certains bouquins, on parlera de chevanome rachidienne. À côté du norinome, on peut avoir un autre type de tumeur qu'on utilise sous le terme d'épandymome de la queue de cheval et qui résulte donc de la prolifération d'un type de cellule nerveuse appelée les épandymomes. Nous avons vu les étiologies des syndromes de la queue de cheval.

Voyons maintenant les principes thérapeutiques. Les principes thérapeutiques sont les mêmes que ceux dont on a parlé quand on a traité les syndromes de compression modulaire. Alors, qu'est-ce qu'on vise quand on veut traiter un syndrome de la queue de cheval? Il faut décompresser les racines de la queue de cheval.

Il faut soulager le malade de ces douleurs et il faut éviter l'évolution vers les complications. Pour répondre à ce but, nous avons un certain nombre de moyens à notre disposition. Ces moyens peuvent être médicaux à base d'antalgiques pour la douleur, d'anti-inflammatoires non stéroïdiens ou de corticoïdes pour les phénomènes inflammatoires, l'antibiotérapie quand il s'agit d'une cause infectieuse comme les spondylodécides et l'héparanno thérapie pour lutter contre l'évolution vers des complications thrombo-emboliques.

(13:21 - 14:12)

À côté des moyens médicaux, on peut faire appel à une rééducation motrice et physico-sphinctérienne. La radio et la chimiothérapie peuvent être proposés quand il s'agit d'une cause

tumorale. Et puis il y a la chirurgie.

La chirurgie comme moyen, ce qu'on vise à travers la chirurgie, c'est de retirer, de faire l'exérèse de l'agent responsable de la compression des racines de la queue de cheval. Et cette exérèse peut être réalisée par voie antérieure, par voie postérieure ou par voie combinée antérieure et postérieure. Mais dans la queue de cheval, sur le plan pratique, la voie d'abord la plus utilisée, c'est la voie postérieure.

(14:12 - 14:59)

Et donc on peut réaliser une laminectomie, une corpectomie. Ces gestes de laminectomie et de corpectomie peuvent nécessiter un geste de ce qu'on appelle une ostéosynthèse, c'est-à-dire des fixations par matériel d'ostéosynthèse pour stabiliser la colonne vertébrale, lombaire et sacrée s'il est instable. L'évolution spontanée, c'est-à-dire si on ne traite pas un syndrome de la queue de cheval, le malade peut s'aggraver sur le plan neurologique et garder des troubles neurologiques irrécupérables et irréversibles.

(14:59 - 15:54)

Le pronostic du syndrome de la queue de cheval comme celui de la compression modulaire, il dépend de deux facteurs, c'est-à-dire les deux facteurs pronostiques qui conditionnent le pronostic de cette entité pathologique sont l'ithiologie. Il y a des ithiologies qui sont de bons pronostics comme l'infection, la hernie discale, le canal lombaire étroit. Il y a des ithiologies qui sont de mauvais pronostics comme la pathologie tumorale maligne. A côté de l'ithiologie, le délai diagnostique et thérapeutique aussi intervient, c'est-à-dire que plus on fait le diagnostic rapidement, plus on traite rapidement et correctement, plus on donne au malade de chance de s'en sortir et de récupérer sur le plan neurologique.

(15:57 - 16:39)

En conclusion, le syndrome de la queue de cheval est un syndrome qui peut intéresser tous les âges. Les deux sexes peuvent être atteints, l'homme et la femme. Son diagnostic est clinique.

La paraclinique trouve son intérêt dans la mise en évidence et la recherche de l'ithiologie responsable de la queue de syndrome de la queue de cheval. Tout syndrome de la queue de cheval, comme le syndrome de compression médullaire, c'est une urgence diagnostique et thérapeutique qu'il faut traiter, diagnostiquer rapidement et traiter précocement et correctement. Je vous remercie.